

DANS CE SUJET

AUTRES SUJETS DANS CE CHAPITRE

→ Perte brutale de la vision

→ Anisocorie

→ Vision trouble

→ Diplopie

→ Œdème des paupières

→ Douleur oculaire

→ Corps flottants

→ Exophtalmie

→ Œil rouge

→ **Larmoiement**

→ Autres symptômes oculaires

# Larmoiement

(Épiphora)

Par **Christopher J. Brady**, MD, Larner College of Medicine, University of Vermont  
Reviewed By **Sunir J. Garg**, MD, FACS, Thomas Jefferson University

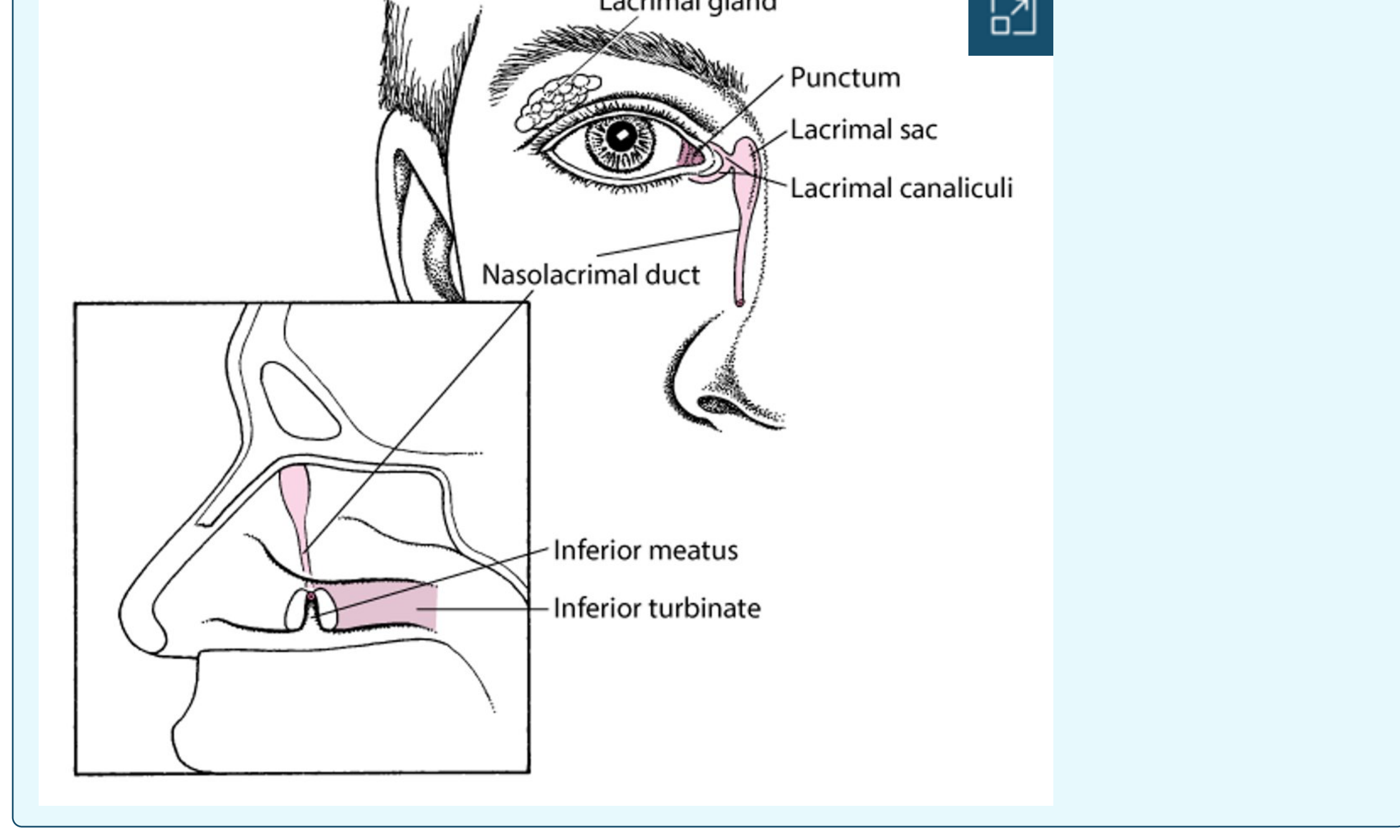
Vérifié/Révisé oct. 2025

**Physiopathologie** | **Étiologie** | **Bilan** | **Traitement** | **Bases de gériatrie** | **Points clés** | **Multimédia**

Un larmoiement excessif peut provoquer une sensation d'yeux remplis d'eau ou entraîner l'écoulement de larmes sur les joues (épiphora).

## Physiopathologie du larmoiement

Les larmes sont produites dans la glande lacrymale et sont drainées à travers les méats lacrymaux supérieurs et inférieurs dans les canalicules et ensuite dans le sac lacrymal et le canal nasolacrymal (voir figure [Anatomie du système lacrymal](#)). L'obstruction du drainage des larmes peut conduire à une stase et des infections. Des infections récidivantes du sac lacrymal ([dacryocystite](#)) peuvent parfois s'étendre, avec possibilité d'entraîner une [cellulite orbitaire](#).



## Étiologie du larmoiement

Habituellement, les causes **les plus fréquentes** du larmoiement sont les suivantes

- Infection des voies respiratoires supérieures
- Rhinite allergique

Le larmoiement peut être provoqué par une augmentation de la production lacrymale ou par une diminution du drainage nasolacrymal. Dans de nombreux cas, la cause du larmoiement peut être multifactorielle.

### Augmentation de la production lacrymale

Les causes les plus fréquentes sont les suivantes

- Infection des voies respiratoires supérieures
- [Rhinite allergique](#)
- [Conjonctivite allergique](#)
- [Yeux secs](#) (réflexe de larmoiement en réponse à la sécheresse de la surface oculaire) (1)
- [Trichiasis](#)

Toute affection provoquant une irritation conjonctivale ou cornéenne peut augmenter la production lacrymale (voir tableau [Certaines causes de larmoiement](#)). Cependant, la plupart des patients qui présentent des troubles cornéens causés d'un excès de larmoiement (p. ex., [érosion de la cornée](#), [ulcère cornéen](#), [corps étranger cornéen](#), kératite) ou qui présentent un [glaucome aigu par fermeture de l'angle](#) ou une [uvéïte](#) antérieure ont initialement d'autres symptômes oculaires que le larmoiement (p. ex., douleur oculaire, rougeur). La plupart des sujets qui ont pleuré ne consultent pas pour un larmoiement.

### Diminution du drainage nasolacrymal

Les causes les plus fréquentes sont les suivantes

- [Sténose idiopathique du canal nasolacrymal](#) liée à l'âge
- [Dacryocystite](#)
- [Ectropion](#)

L'obstruction du système de drainage nasolacrymal peut être provoquée par des sténoses, des tumeurs ou des corps étrangers (p. ex., calculs, fréquemment associés à une infection infraclinique par *Actinomyces*). L'obstruction peut également être une malformation congénitale. De nombreux troubles et médicaments peuvent provoquer une sténose ou une obstruction du drainage nasolacrymal.

Les autres causes de sténose ou d'occlusion du drainage nasolacrymal comprennent

- Les brûlures
- Médicaments de chimiothérapie
- Les collyres (particulièrement l'iodure d'échothiophate, l'adrénaline et la pilocarpine)
- L'infection, dont les [canaliculites](#) (p. ex., causées par *Staphylococcus aureus*, *Actinomyces*, *Streptococcus*, *Pseudomonas*, les conjonctivites à herpes zoster et à herpes simplex, la mononucléose infectieuse, le papillomavirus humain, l'infestation par l'*Ascaris*, la lèpre, la tuberculose)
- Les maladies inflammatoires ([sarcoïdose](#), [granulomatose avec polyangéïte](#))
- Les blessures (p. ex., les fractures naso-ethmoidales; nasales, orbitaires ou la chirurgie endoscopique des sinus)
- Une obstruction de l'orifice nasal malgré une voie nasolacrymale intacte (p. ex., infection des voies respiratoires supérieures, rhinite allergique, [sinusite](#))
- La radiothérapie
- [Syndrome de Stevens-Johnson](#)

### Référence pour l'étiologie

1. [Akpek EK, Amescua G, Farid M, et al.](#) Dry Eye Syndrome Preferred Practice Pattern®. *Ophthalmology*. 2019;126(1):P286-P334. doi:10.1016/j.optha.2018.10.023

## Évaluation d'un larmoiement

### Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** comprend la durée, le début et la gravité des symptômes, dont le fait que les larmes s'écoulent le long des joues (épiphora vrai). Les effets des conditions atmosphériques, de l'humidité environnementale et de la fumée de cigarette sont précisés.

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes des causes possibles, tels que prurit, rhinorrhée ou éternuements, en particulier lorsqu'ils surviennent à longueur d'année ou après l'exposition à des allergènes spécifiques potentiels (réaction allergique); une irritation oculaire ou une douleur ([blépharite](#), [érosion de la cornée](#), irritants chimiques); et une douleur près de l'angle interne ([dacryocystite](#)). Les autres symptômes sont de moindre importance, mais doivent être recherchés; ils comprennent les céphalées positionnelles, une rhinorrhée purulente, une toux nocturne et de la fièvre ([sinusite](#), [granulomatose avec polyangéïte](#) [anciennement appelée maladie de Wegener]); une éruption cutanée ([syndrome de Stevens-Johnson](#)); une toux, une dyspnée et une douleur thoracique ([sarcoïdose](#)); et une épistaxis, une hémoptysie, des polyarthralgies et des myalgies ([granulomatose avec polyangéïte](#)).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur des causes connues de larmoiement, dont la granulomatose avec polyangéïte ([anciennement appelée granulomatose de Wegener](#)), la [sarcoïdose](#) et le [cancer traité par chimiothérapie: les affections qui provoquent les yeux secs](#) (p. ex., [polyarthrite rhumatoïde](#), [sarcoïdose](#), syndrome de Sjögren); et les médicaments, comme l'échothiophate, l'adrénaline et la pilocarpine. Les antécédents oculaires et d'affections nasales, dont infections, blessures, procédures chirurgicales et exposition aux radiations, sont précisés.

### Examen clinique

L'examen se concentre sur les yeux et les structures environnantes.

La face est inspectée; une asymétrie suggère une obstruction congénitale ou acquise du drainage par le canal nasolacrymal. Lorsque cela est possible, une lampe à fente doit être utilisée pour examiner les yeux. Les conjonctives et les cornées sont inspectées à la recherche de lésions, dont des taches ponctuées et une rougeur. La cornée est colorée avec la fluorescéine et examinée. Les paupières sont retournées pour détecter des corps étrangers cachés. Les paupières, et les méats lacrymaux, sont soigneusement examinés à la recherche de corps étrangers, blépharite, [orgelets](#), [ectropion](#), [entropion](#) et [trichiasis](#). Le sac lacrymal (près de l'angle interne) est palpé à la recherche d'une chaleur, d'une sensibilité et d'un gonflement. Tous les gonflements sont palpés pour apprécier leur consistance et voir si du pus est exprimé.

Le nez est examiné à la recherche de congestion, purulence et d'hémorragies.

### Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Épisodes de larmoiement répétés et inexpliqués
- Masse dure à proximité ou dans les structures de drainage nasolacrymales

### Interprétation des signes

Les signes qui suggèrent une obstruction du drainage nasolacrymal comprennent:

- Un larmoiement le long des joues (épiphora vrai)
- Absence d'une cause spécifique différente

Pour une liste des causes fréquentes qui peuvent être évidentes lors de l'évaluation ophtalmologique, voir tableau [Certaines causes de larmoiement](#).

### Examens complémentaires

Les examens complémentaires sont souvent inutiles parce que la cause est habituellement évidente à partir de l'examen clinique.

Un test de Schirmer avec une grande humidification du buvard (p. ex., > 25 mm) indique une [sécheresse oculaire par évaporation](#) comme étiologie du larmoiement. Un test de Schirmer avec très peu d'humidification du buvard (< 5,5 mm) suggère une [sécheresse oculaire par déficience de larmes](#). Habituellement, le test de Schirmer est fait par un ophtalmologiste pour être sûr qu'il est effectué et interprété correctement.

Le sondage et l'irrigation par du sérum physiologique de la voie lacrymale peuvent détecter une obstruction anatomique du drainage, ou bien une sténose due à une occlusion complète du drainage nasolacrymal. L'irrigation est effectuée avec ou sans fluorescéine. Un reflux à travers le méat lacrymal opposé (p. ex., le punctum lacrymal supérieur de l'œil si le punctum lacrymal inférieur était irrigué) ou le canalicule opposé est le signe d'une occlusion fixée; un reflux et un drainage dans le nez indiquent une sténose. Ce test est considéré comme adjuvant et est effectué par les ophtalmologistes.

L'imagerie médicale et certaines techniques (la dacryoscintigraphie, la dacryocystographie, la TDM, l'endoscopie nasale) sont parfois utiles pour délimiter une anomalie anatomique lorsque la chirurgie est envisagée ou parfois pour détecter un abcès. La [dacryocystite](#) infectieuse récidivante peut évoluer en d'autres maladies plus sérieuses telles que la [cellulite orbitaire](#).

## Traitement du larmoiement

Les affections sous-jacentes (p. ex., allergies, corps étrangers, conjonctivite) sont traitées.

L'utilisation de larmes artificielles diminue paradoxalement le réflexe de lacrimation lorsque les yeux secs ou des anomalies épithéliales cornéennes en sont la cause.

L'obstruction congénitale du canal nasolacrymal ([dacryosténose](#)) se résout souvent spontanément. Chez les patients de < 1 an, une compression manuelle du sac lacrymal 4 ou 5 fois par jour peut soulager l'obstruction distale. Après l'âge de 1 an, un sondage du canal nasolacrymal peut être nécessaire, sous anesthésie générale. Si l'obstruction récidive, une intubation temporaire de drainage peut être placée.

En cas d'une obstruction acquise du canal nasolacrymal, l'irrigation du canal peut être thérapeutique lorsque les causes sous-jacentes ne répondent pas au traitement. En dernier recours, une ouverture entre le sac lacrymal et la cavité nasale peut être créée chirurgicalement (dacryocystorhinostomie).

En cas de sténose du point lacrymal ou du canalicule, la dilatation est habituellement curative. Si le rétrécissement canaliculaire est sévère et gênant, une intervention chirurgicale peut être envisagée qui consiste à placer un tube de verre à partir de la caroncule jusque dans la cavité nasale.

## Bases de gériatrie: larmoiement

La sténose idiopathique du canal nasolacrymal liée à l'âge est la cause la plus fréquente d'épiphoras inexpliqués chez les patients âgés; cependant, une tumeur doit également être évoquée.

## Points clés

- Si les larmes ne coulent pas sur les joues, les yeux secs sont souvent la cause.
- Si les larmes coulent sur les joues, une obstruction du drainage nasolacrymal est probable.
- Les examens (dacryocystographie, TDM, endoscopie nasale) sont souvent inutiles, mais peuvent être nécessaires lorsque la chirurgie est envisagée ou parfois pour détecter un abcès lorsqu'une infection est suspectée.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Take a Quiz!

Téléchargez gratuitement l'application Manuels MSD

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play